



Centre des opérations d'urgences de sante publique « COUSP-RDC »

Rapport de Situation de la Maladie à Virus Ebola/16ème épidémie

SitRep MVE N° 36/MVE_16/2025

Pays/Province	RDC/Kasaï
Zone de Santé touchée	BULAPE
Date de rapportage	11 octobre 2025
Date de publication	12 octobre 2025

53	11	34	5,5 %	43,7 %	18	37 240	26 557
Cas Confirmés	Cas probables	Décès confirmés	Taux d'occupation des lits chez les confirmés	Taux d'occupation des lits chez les suspects	Guéris	Doses de vaccin déployées	Personnes vaccinés

I. POINTS SAILLANTS

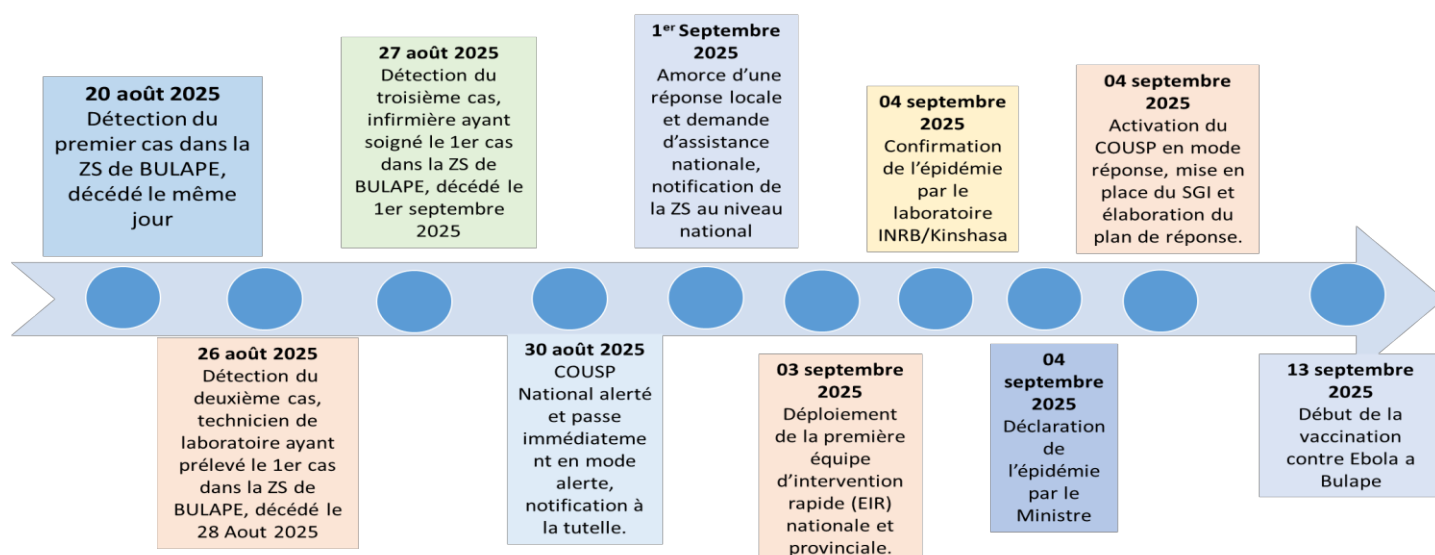
- ☒ Aucun nouveau cas n'a été confirmé en ce jour.
- ☒ Un (1) décès d'un cas confirmé survenu au CTE HGR Bulape.
- ☒ Construction du CT Bulape communautaire par ALIMA de 5 lits individualisés par chambre avec toilettes par chambre
- ☒ Déploiement des équipes multidisciplinaires à Mweka et à Kakenge

NARRATIF DU CAS INDEX (Contexte)

Le 20 août 2025, une femme enceinte de 20 ans a été admise au service de gynéco-obstétrique de l'HGR de Bulape, présentant la fièvre, la diarrhée sanglante, des vomissements hémorragiques et une anémie sévère. Elle est décédée quelques heures plus tard dans un tableau de défaillance multi viscérale. Dans les jours qui ont suivi, un technicien de laboratoire et une infirmière ayant été en contact avec la patiente ont manifesté les mêmes symptômes et sont également décédés. Entre les semaines épidémiologiques 34 et 36, treize cas ont été notifiés, dont huit décès, soit un taux de létalité de 62 %. L'épidémie a été officiellement déclarée à la suite de la confirmation de cinq cas positifs par l'INRB en date du 04 septembre 2025.



II. CHRONOLOGIE DES FAITS MARQUANTS



III. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

- ☑ Aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié en date du 11/10/2025.
- ☑ La date de la dernière notification d'un cas confirmé remonte au 26 septembre 2025. Ainsi, nous sommes au quinzième jour sans notification d'un cas confirmé.
- ☑ Un (1) nouveau décès a été notifié parmi les confirmés.
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 64 cas (53 confirmés et 11 probables) dont 45 décès ont été rapportés dans la zone de santé de Bulape, soit une létalité globale de 70,3% (Tableau I).
- ☑ La létalité parmi les cas confirmés est de 64% (34 décès/53 cas confirmés).
- ☑ Le nombre d'aires de santé ayant notifié au moins un cas confirmé ou probable de MVE depuis le début de l'épidémie demeure à 6 (28,6%) sur les 21 que compte la ZS de Bulape (Tableau I ; Figure 2).

Tableau I : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, au 11 octobre 2025

Aire de santé affectée*	Nouveau(x) cas confirmé(s)	Cumul des cas et décès				Date de notification du dernier cas confirmé	Nombre de jours sans nouveau cas notifié
		Confirmés	Décès confirmés	Létalité (%)	Probables		
Bambalaie	0	4	2	50,0%	0	20/09/2025	22
Bulape	0	16	14	87,5%	8	26/09/2025	15
Bulape com.	0	4	4	100,0%	1	20/09/2025	21
Dikolo	0	25	14	56%	1	26/09/2025	15
Ingongo	0	1	0	0,0%	0	13/09/2025	26
Mpianga	0	3	0	0,0%	1	22/09/2025	18
Total	0	53	34	64,2%	11		

**Les cas et les décès sont répartis par aire de santé de détection et ces chiffres sont susceptibles de changer.*

On observe depuis quelques jours, une hausse de la létalité dans l'AS de Bulape passant de 64,7% le 05/10/2025 à 87% à ce jour. Cependant, la létalité la plus élevée est attribuable à l'aire de santé de Bulape Com, soit un taux de létalité de 100 %. Par ailleurs, les aires de santé de Bulape et de Dikolo détiennent la majorité des cas confirmés ainsi que des décès enregistrés.

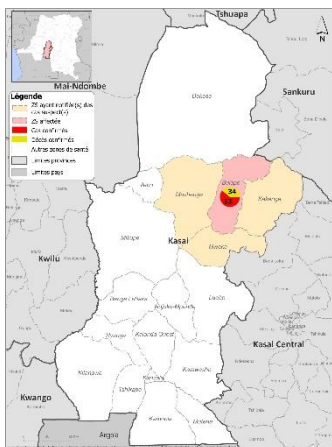


Fig 1. Répartition géographique des zones de santé affectées par la MVE et celles à risque dans la province du Kasai, au 11 octobre 2025

La ZS de Bulape demeure l'unique ZS avec des cas confirmés et des décès sur l'ensemble des ZS ayant notifiés des cas suspects. A ce jour, la létalité est à 64,2%

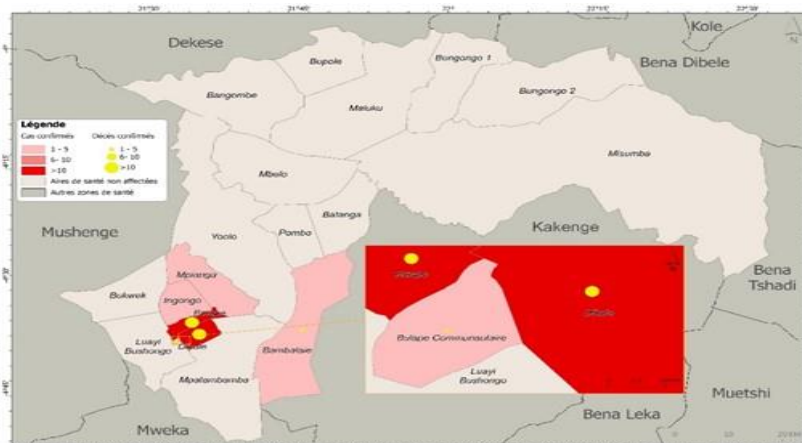


Fig 2. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 11 octobre 2025

Les aires de santé de **Bulape** et de **Dikolo** sont les plus touchées, à la fois en terme du nombre de cas confirmés et des décès enregistrés.

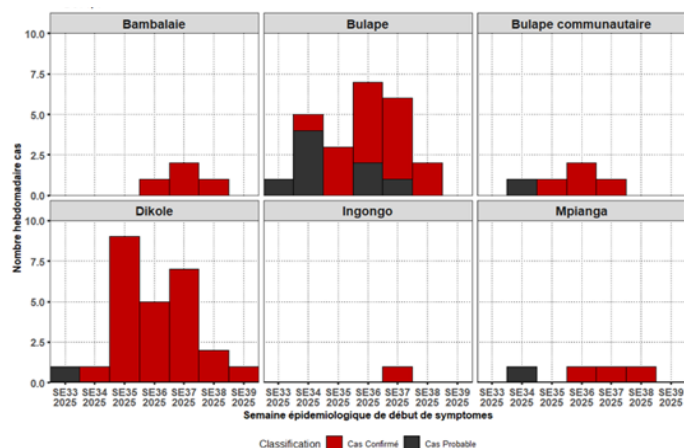


Fig 2. Répartition géographique des cas confirmés et probables par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 11 octobre 2025

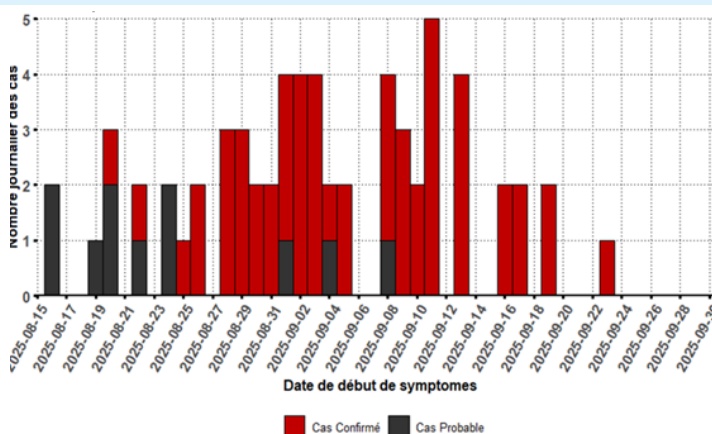


Fig 4. Evolution journalière des cas confirmés et probable au 11 octobre 2025.

En considérant les AS de BULAPE et DIKOLO comme principaux foyers de l'épidémie dans la ZS de Bulape, il ressort que durant les SE 35 à 36, l'AS de Dikolo a enregistré le plus grand nombre de cas notifiés. Cependant, à partir de la SE37 jusqu'au SE38, une tendance à la hausse des cas confirmés est observée dans l'AS de Bulape

Sur la période allant du 27 Aout au 13 septembre, l'analyse journalière met en évidence la survenue de trois clusters des cas confirmés. Par la suite, à compter du 15 septembre ; les notifications deviennent sporadiques, traduisant une

Tableau 2. Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par aire de santé, du 11 octobre 2025

INDICATEURS	05/09/2025	06/09/2025	07/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	11/10/2025
Report alertes	9	8	2	4	10	6	6
Nouvelles alertes signalées du jour	34	26	26	39	6	41	29
Total alertes du jour	43	34	28	43	16	47	35
Alertes investiguées du jour	35	33	17	32	10	33	23
Alertes validées du jour	10	15	7	20	6	16	12
Suspects prélevés	8	9	0	20	5	8	8
Transférés au CTE	8	9	7	10	5	4	8

NA : non applicable ; ND : non disponible

Le nombre moyen d'alertes journalières rapportées cours de 7 derniers jours (du 05/10/2025 au 11/10/2025) est de 35. Parmi les alertes du jour, deux MAPI ont été signalées.

Tableau 3. Synthèse de la situation du suivi de contacts au 11 octobre 2025

Aire de Santé	Suivi journalier						Taux de suivi	Total non vus	Raison de non vus						
	Report du 10/10/2025	Nouveaux contacts du 11/10/2025	Contact à suivre ce jour	Contacts vus	Sorties 21 Jrs	Devenus Suspects			Simple Absence	Perdus de vue (≥72 heures)	Jamais vus	Refus	Déplacés	Reco n'est pas passé	Reste à suivre le jour suivant
Bambalayi	27	0	27	27	27	0	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulape	164	0	164	157	41	0	95,7%	7	0	0	0	0	7	0	123
Bulape Com	208	0	208	201	177	0	96,6%	7	0	0	0	0	7	0	31
Dikolo	155	0	155	116	0	0	74,8%	39	10	28	0	0	1	0	155
Ingongo	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0
Mpianga	18	0	18	18	18	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	18
Total	572	0	572	519	245	0	90,7%	53	10	28	0	0	15	0	327

*Pour un ensemble de 572 contacts à suivre, 519 contacts ont été vus soit une proportion de suivi de 90,7%.
Vingt-huit (28) contacts sont perdus de vue et quinze (15) sont en déplacement.*

IV. ACTIONS DE REPONSE

COORDINATION

- ☒ Visite de son Excellence Ministre de Santé Publique Hygiène et Prévoyance Sociale accompagné du DG de l'INSP, les Représentant PTF ainsi que Ministre provincial de sante publique à Bulape
- ☒ Inauguration du nouveau CTE
- ☒ Remise des matériels par son Excellence Ministre de Santé Publique Hygiène et Prévoyance Sociale

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- ☒ Un EDS a été réalisé à la suite d'un décès survenu au CTE le jour 15, sans nouveau cas confirmé associé. Deux (2) nouveaux décès parmi les cas confirmés ont été notifiés les 10 et 11 octobre 2025 au nouveau CTE, les patients étant dans un état critique à l'admission.
- ☒ Le nettoyage des bases de données de surveillance (suivi des contacts et liste linéaire des cas) est réalisé à 70 %

Points sur la surveillance aux Points d'entrée et Points de Contrôles (PoE/PoC)

- ☒ Pour la journée du 11 octobre 2025, un total de 4 943 voyageurs ont été enregistrés dans les 5 PoC opérationnels (4 à Bulape et 1 à Luebo). Parmi eux, 4 881 personnes (99,3 %) ont été screenées et ont procédé au lavage des mains. **Cinq** alertes signalées au cours de cette journée.

LABORATOIRE

- ☑ Pour la journée 11/10/2025, 30 échantillons ont été reçus (15 nouveaux cas suspects dont 2 de Mweka et 15 réprélèvements). De tous les échantillons de réprélèvement ; un est revenu positif ; il s'agit du 8^{ème} réprélèvement d'un cas sous traitement. Aucun nouvel échantillon des cas suspects n'est revenu positif.
- ☑ De tous les échantillons analysés depuis le début, 53 cas confirmés ont été diagnostiqués positifs à la MVE.
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 658 échantillons ont été reçus et 650 ont été analysés.

Tableau 4. Synthèse de la situation des échantillons reçus et analysés au laboratoire du 09 octobre 2025

Indicateurs	Données
Échantillons reçus (total)	30
Nouveaux cas suspects	15
Réprélèvements	15
Échantillons analysés	20
Réprélèvements analysés	14 (1 positif)
Résultats des tests	
En cours d'analyses	8
Cas confirmés du jour	0
Non-cas du jour	8
Total non-cas	327
Total des cas confirmés	53

PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE (MÉDICALE, NUTRITIONNELLE & PSYCHOSOCIALE)

Tableau 4. Situation des patients hospitalisés dans les centres de traitement Ebola (CTE), centre de transit (CT) ou assimilés en date du 11 octobre 2025

CI/CT/CTE	Cas suspects				Cas confirmés			Guéris	
	Nombre de lits	Nouvelle admission	Total cas au terme de la journée	Taux d'occupation (%)	Nombre de lits	Nombre de cas	Taux d'occupation (%)	Guéris du jour	Cumul guéris
CTE HGR Bulape	16	4	6	37,5%	18	1	5,5%	0	18
CT Bambalayi	8	3	4	50%	0	0	0%	0	0
CT Ingongo	4	2	4	100%	0	0	0%	0	0
CT Mpianga	4	0	0	0,0%	0	0	0%	0	0
Total	32	9	14	43,7%	18	1	5,5%	0	18

- ☑ Au cours de la journée du 11 octobre 2025, les structures de prise en charge ont enregistré 9 nouvelles admissions, dont 4 au CTE HGR Bulape, 3 au CT Bambalayi et 2 au CT Ingongo. Au total, 15 patients sont hospitalisés, dont 14 cas suspects et 1 cas confirmés de MVE, avec des taux d'occupation de 43,7 % pour les suspects et 5,5 % pour les confirmés.
- ☑ Un patient confirmé est décédé au CTE HGR Bulape au cours de la journée du 11.
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 18 personnes ont été déclarées guéries et sorties du CTE et le traitement spécifique (Mab114/Ebanga) a été administré à 31 patients.

Activités phares du pilier

- ☒ Construction du CT Bulape communautaire par ALIMA de 5 lits individualisés par chambre avec toilettes par chambre
- ☒ Narratif du décès du 10/10/2025

PREVENTION ET CONTRÔLE DE L'INFECTION (PCI/WASH)

- ☒ Evaluation du PS Bon Berger (score 3%)
- ☒ Actions immédiates menées : Briefing de 4 prestataires des soins sur les précautions standards et quelques actions correctrices immédiates sur l'hygiène des mains, des matériels et de l'environnement du patient.

VACCINATION

- ☒ Tenue de la réunion du pilier vaccination
- ☒ Poursuite de la vaccination géographique

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- ☒ Prise des contacts et Plaidoyer auprès du chef de groupement de Mpianga pour solliciter son implication dans les différentes activités menées au PoC Mpianga: Très engagé est disposé à contribuer à la réponse;
- ☒ Briefing des Acteurs au PoC Mpianga et Mpatambamba sur l'utilisation de l'outil de collecte de feed-back communautaire sur les actions de PoC;
- ☒ Séance de travail avec ALIMA et INRB sur le Projet EBO-PEP
- ☒ Séance de travail avec l'OMS

LOGISTIQUE

- ☒ Approvisionnement des différents piliers en intrants essentiels.
- ☒ Appui logistique au déploiement des équipes sur le terrain (vaccination, PCI, épidémiologie et prise en charge à Mweka et Kakenge).
- ☒ Tenue de la réunion du pilier logistique avec la participation des partenaires : UNICEF, Croix-Rouge et Ministère de la Santé.
- ☒ Réception de 1000 litres d'essence de la part de l'UNICEF.
- ☒ Mise à disposition de 3 véhicules de location remis par l'UNICEF.
- ☒ Élaboration du rapport mensuel de la logistique (version draft 1).
- ☒ Poursuite du rodage des motos.
- ☒ Installation du courant électrique à la tente principale de la coordination.
- ☒ Suivi de l'électrification de la nouvelle maison destinée aux experts de l'INSP

SURETE ET SECURITE

- ☒ Briefing PRSEAH de 42 et 9 femmes et signature de 27 code de bonne conduite de experts de riposte contre la MVE
- ☒ Séances de sensibilisation PRSEAH communautaire de 748 participants dont 405 filles et femmes dans les villages Ndengeshi, village Tshikapa, école main de Dieu, villages Tshitekeshi et Tdhilomba
- ☒ Début d'évaluation d'état de stress des experts de la riposte à la coordination

IV. DEFIS ET GAPS

- ☑ Mauvais état de route pour atteindre les différents villages des AS affectées.
- ☑ Insuffisance des ressources pour la mise en place d'une réponse holistique.

V. PERSPECTIVES

- ☑ Effectuer un suivi pour l'installation des laboratoires de diagnostic de la MVE à Tshikapa.
- ☑ Déployer rapidement les psychologues cliniciens afin de mieux couvrir cette thématique dans le cadre la réponse à la MVE.
- ☑ Faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour accélérer la mise à dispositions des fonds alloués à la réponse.
- ☑ Déployer les ressources humaines additionnelles pour renforcer les différents piliers de la réponse (+++ Surveillance et gestion des données).

VI. PHOTOS DE TERRAIN

Prise des contacts et Plaidoyer auprès du chef de groupement de Mpianga



Briefing PRSEAH de 42 et 9 femmes et signature de 27 code de bonne conduite de experts de riposte contre la MVE



**POUR TOUTE
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

Tel. : +243 816 040 145

E-mail : dieudonnemwambakazadi@gmail.com

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

Tél. : +243998091915

E-mail : nganduchristian@ymail.com

L'Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

E-mail : Richard.kitenge@insp.cd

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr ELOVAINIO Riku Edward

E-mail : elovainior@who.int

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE

Dr Mory Keita

E-mail: makeita@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int

